EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 93061
SERVICIO : UCI HSC
FECHA : 2024-09-17 14:15:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA ETELINDA ERICES RIVAS			RUN	: 14.240.019-7
F.Nac	: 10-01-1974	Edad	: 50 AÑOS, 8 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: BULI ESTACION			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 81806623		
Fecha Ingreso	: 2024-09-11	Fecha Egreso	: 2024-09-17 14:15:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J46.X-ASMA AGUDA SEVERA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA HIPOXEMICA (RESUELTA)
2. ASMA BRONQUIAL EXACERBADA CON COMPONENTE VENTILARIO MIXTO (RESTRICTIVO-OBSTRUCITVO)
3. INFECCION POR RINOVIRUS
4. DM TIPO 2
5. HTA
6. BRADICARDIA SINUSAL
7. FA PAROXISTICA CHA2DS2VASC 2 PTOS
8. OBS ENFERMEDAD CORONARIA CRÓNICA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J45.9E-ASMA, NO ESPECIFICADA CON EXACERBACIONES (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E10-E14-DIABETES MALLITUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. J20.6-BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A RINOVIRUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE FEMENINO DE 50 AÑOS DE EDAD, RECIENTEMENTE HOSPITALIZADA EN HSC DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE Y LUEGO A HODOM POR ASMA EXACERBADA, SIENDO DERIVADA DESDE HODOM POR REFERIR DISNEA, DESATURACIÓN, TAQUIPNEA, MALA MECANICA VENTILATORIA Y USO DE MUSCULATURA ACCESORIA, POR LO QUE INGRESA A SERVICIO DE URGENCIAS HIPERTENSA PA 172/108 MMHG TAQUICARDICA FC 102 TAQUIPNEICA FR 28 RPM, CON SIBILANTES AUDIBLES, MARCADA DISNEA AL HABLA, SATURANDO 94%, EN SERVICIO DE URGENCIA SE INICIA MANEJO CON BRONCODILATACION Y CORTICOIDES EV, CON ESCASA RESPUESTA, SE SOLICITA EVALUACIÓN POR RESIDENTE UCI PARA PROBABLE MANEJO CON VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA .
EVOLUCIÓN INTRAHOSPITALARIA:
HEMODINAMIA: INGRESA A URGENCIA HIPERTENSA Y TAQUICARDICA PERO A UCI YA MEJORA PA 160/80 Y FC 81, LUEGO DE CONEXIÓN A VMNI, SE ESTABILIZA MÁS, MANTENIENDOSE NORMOTENSA Y PROGRESIVAMENTE Y DURANTE TODA LA HOSPITALIZACIÓN CON TENDENCIA A BRADICARDIA SINUSAL + ARRITMIA SINUSAL RESPIRATORIA. ADEMAS SE APRECIA ONDA T NEGATIVA AL MONITOR MIENTRAS QUE EN EKG LESION SUBENDOCARDICA CARA INFERIOR, CARA LATERAL ALTA Y BAJA. SE RESCATA HOLTER DE ARRITMIAS DE JULIO 2024 DONDE DESTACA BRADICARDIA SINUSAL ALTERNADA CON FIBRILACIÓN AURICULAR Y EXTRASISTOLES SPV Y VENTRICULARES ESCASOS. BH (+)180 BHA (-)1430 ML. SE INDICA ANTICOAGULACION CON APIXABAN, SE REALIZA ETT DONDE NO SE EVIDENCIA TRASTORNOS DE MOTILIDAD SEGMENTARIA, FEVI NORMAL, SIN VALVULOPATIAS, AURICULAS NO DILATADAS.
RESPIRATORIO: INGRESA A URGENCIAS CON FR 28 SATURANDO 94% FIO2 50% PAFI 287 , SIN ALTERACION

DEL ESTADO DE CONSCIENCIA, DISNEA AL HABLAR, TAQUICARDICA 102, UMA PCO2 33.6 Y PO2 115, EN ESTE CONTEXTO CALIFICA PARA CRISIS MODERADA-GRAVE, PERO TRAS BOLOS DE HIDROCORTISONA Y NBZ MEJORA Y SE CONECTA A VMI, INCIALMENTE FIO2 100%, PERO EN 1 HORA SE DISMINUYE A 24% IPAP 12 EPAP 8 Y AS SE MANTUVO SIN VENTANAS LAS 1ERAS 36 HORAS, CON PAFI 338-461, FR 15-24 RPM SIN UMA Y FC 55-60, LUEGO SE INICIAN VENTANAS LAS CUALES SON BIEN TOLERADAS Y ESE MISMO DÍA (13/09/2024) NO SE CONECTA DE NUEVO Y QUEDA CON FIO2 21%. IGUALMENTE SE DA BOLO DE METILPREDNISOLONA 250 MG VEV Y SE MANTIENE POR HORARIO 100 MG C/8H Y RECIBE SUS INHALADORES + NBZ CON BERODUAL. ACTUALMENTE FR 17-18 RPM, COMPLETA 48 H SIN CONEXIÓN A VMNI, SATURANDO 90-95% PAFI 303, TOS PRODUCTIVA MENOS FRECUENTE . RECIBE INHALADORES RELVAR ELLIPTA Y SPIRIVA RESPIMAT.
INFECCIOSO: INGRESA A HSC Y UCI AFEBRIL, PARAMETROS INFLAMATORIOS LEVEMENTE AUMENTADO PCR 16.9 QUE ASCIENDE HASTA 33.7, SE AISLA RINOVIRUS EN PANEL VIRAL RESPIRATORIO, SE INDICA EMPIRICAMENTE CEFTRIAXONA QUE CUMPLE DURANTE 4 DÍAS, ACTUALMENTE AFEBRIL, PARAMETROS INFLAMATORIOS BAJOS , PCR 6.6, HEMOCULTIVOS 11/09/2024 HASTA AHORA SIN AISLAMIENTO.
NEFROMETABÓLICO: DIURESIS Y PRUEBAS DE FUNCIONALISMO RENAL CONSERVADAS DESDE EL INGRESO PERO SIEMPRE REQUIRIENDO BOLO DE FUROSEMIDA POR PARCIAL DE LAS 12 H DIA SIEMPRE OLIGURIA Y BH (+) PERO CON ADECUADA RESPUESTA. TAMBIEN HIPERGLICEMIAS POSTERIOR A BOLO DE METILPREDNISOLONA PERO TRAS AJUSTE DE INSULINOTERAPIA SE LOGRA CONTROLAR

PLAN DE MANEJO:

HODOM

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. REPOSO RELATIVO
2. 2. REGIMEN LIVIANO PARA DIABÉTICOS
3. 3. AZITROMICINA 500 MG: 1 COMPRIMIDO AL DIA (LUNES-MIERCOLES-VIERNES)
4. 4. PREDNISONA 40 MG X VO 1 VEZ AL DÍA POR 15 DIAS (LUEGO DISMINUIR 5 MG DIA DIARIO HASTA LLEGAR A 5 MG Y MANTENER DIA POR MEDIO)
5. 5. APIXABAN 5 MG: 1 COMPRIMIDO X VO CADA 12 H
6. 6. PARACETAMOL 1 GR X VO CADA 8 HRS SOS
7. 7. ELCAL D 1 COMPRIMIDO 1 VEZ AL DÍA
8. 8. SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MCG: 1 INHALACIÓN 1 VEZ AL DÍA
9. 9. RELVAR ELLIPTA 184/22 MCG: 1 INHALACIÓN 1 VEZ AL DIA
10. 10. SALBUTAMOL 100 MCG: 2 PUFF X AEC CADA 6 H (CUANDO TENGA CRISIS)
11. 11. BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG: 2 PUFF X AEC CADA 6 H
12. 12. OMEPRAZOL 20 MG X VO CADA 24 H
13. 13. ATORVASTATINA 40 MG: 1 COMPRIMIDO 1 VEZ AL DÍA (21:00 H)
14. 14. HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG: 1/2 COMPRIMIDO 1 VEZ AL DÍA
15. 15. INSULINA NPH: 8:00 H 6 UDS VSC/22:00 H 6 UDS VSC
16. 18. KINE R/M

EXÁMENES Y RESULTADOS

LAB 17/09/2024: CREA: 0.7 PCR: 6.5 NA+: 137 K+: 3.5 CL: 99 PH: 7.48 PCO2: 35 PO2: 73 HCO3: 27 SYO2: 93 PAFI: 350

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

CRISMAR KARINA IBAÑEZ ROMERO
MEDICO TRATANTE
26788003-4

JEFE SERVICIO